

## RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5098574-61.2024.4.02.5101/RJ

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

**RECORRENTE:** IZALDO LAURENTINO DA SILVA

**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

**RECORRIDO:** ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**RECORRIDO:** MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

**MEDIDA DE URGÊNCIA. SAÚDE. PRIMEIRO ATENDIMENTO EM ONCOLOGIA. COMPROVADA A NECESSIDADE E URGÊNCIA. DIAGNÓSTICO DADO HÁ MAIS DE 60 DIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.**

### ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para que os réus providenciem, dentro de suas esferas de atuação, o agendamento da consulta em oncologia (Ambulatório 1ª vez) no âmbito do SUS para avaliação e início do tratamento oncológico no prazo de 10 dias. Sem custas e honorários. Publique-se. Intime-se. Após o decurso de prazo, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5098574-61.2024.4.02.5101

510015362310 .V3

## RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5098574-61.2024.4.02.5101/RJ

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

**RECORRENTE:** IZALDO LAURENTINO DA SILVA

**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

**RECORRIDO:** ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**RECORRIDO:** MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

### RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência interposta pela parte autora em face da decisão do Juízo de origem que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela nos seguintes termos. Vejamos:

*"1. Concedo à parte autora a prioridade na tramitação do feito. Anote-se.*

*2. Concedo a gratuidade de justiça, à vista da presunção de hipossuficiência econômica que decorre da representação pela DPU, circunstância materializada pelos documentos financeiros que acompanham a inicial (ev. 1, out2, fls. 7/12).*

*3. A tutela de urgência está prevista no artigo 300 do CPC e possui os seguintes requisitos para o seu deferimento: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.*

*No caso dos autos, o autor foi diagnosticada com neoplasia maligna do cólon, sendo inserido no sistema de regulação, com fito à consulta oncológica, na data de 05/07/2024 (ev. 1, out2, fl. 21).*

*Afirma que necessita, com extrema urgência, do início do tratamento, por meio da "consulta em ambulatório 1ª vez - Coloproctologia (Oncologia)".*

*Finalmente, salienta que ainda aguarda em fila o atendimento, aduzindo violação ao prazo previsto na Lei nº 12.732/2012.*

*Pois bem.*

*Não se desconhece o disposto na Lei nº 12.732/2012 no sentido de que "o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em*

*que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único” (art. 2º).*

*Ocorre que a organização da fila de espera é baseada em critérios médico-científicos, de maneira que a intervenção do Poder Judiciário só pode se dar em hipóteses excepcionais, em casos de flagrante desrespeito à regulação ou de urgência devidamente comprovada, nos termos do Enunciado 51 da II Jornada de Saúde do CNJ:*

*“ENUNCIADO Nº 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência **requer relatório médico circunstanciado**, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.”*

*Nesse aspecto, constata-se que a parte autora traz aos autos apenas resultados de exames e relatório de alta hospitalar relativo a procedimento cirúrgico para desobstrução intestinal (ev. 1, out2, fls. 16/19), pelos quais não é possível verificar descrição de quadro clínico de risco imediato a caracterizar urgência quanto à consulta oncológica.*

*Desse modo, este magistrado não tem elementos bastantes para afirmar que a condição do autor é mais grave que a dos demais pacientes que também se encontram aguardando início do tratamento, de modo que, nas atuais circunstâncias, o deferimento do pleito seria temerário e caracterizaria indevida ingerência na autonomia administrativa do Poder Executivo.*

*Diante da instrução ainda incipiente, infere-se que é preciso respeitar a fila, da forma como organizada, de acordo com a disponibilidade de vagas, sem que possa o juízo prejudicar outras pessoas em igual ou até pior situação, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.*

*Por tudo, a resolução qualificada do caso, mesmo que em sede provisória, demanda, no mínimo, maior aprofundamento da instrução, o que impede, por ora, a concessão da medida requerida, sem prejuízo de nova análise em caso de alteração das circunstâncias atuais.*

*Ante o exposto, **INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.**”*

Alega a parte recorrente que necessita, com urgência, de consulta com médico oncologista, já que foi diagnosticada com neoplasia maligna do cólon (CID 10 C18 e 18.7), conforme exame anátomo patológico com resultado em **14/05/2024**.

Alega que o Juízo *a quo* deixou de conceder a tutela de urgência, sem ao menos ter intimado o NAT para apresentar parecer.

Observando que nos autos originários não houve determinação de intimação do NAT para apresentar parecer, foi determinada, em grau de recurso, a intimação do NAT.

O NAT juntou parecer no evento 16.

## **VOTO**

Verifica-se que o NAT, em seu parecer, confirmou a necessidade e urgência na realização da consulta pretendida, e que a parte autora ainda aguarda em fila, ocupando a posição 35º.

Assim, tendo em vista que não houve alteração no quadro fático, mantenho o já fundamentado na decisão do evento 8, passando a referida fundamentação a fazer parte do presente voto. Vejamos:

Observa-se dos autos que o autor juntou documentos médicos que comprovam que desde 04/2024 já relatam diagnóstico de neoplasia maligna do cólon sigmóide (evento 1, out2, pág. 16).

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS  
AV. LOBO JÊNIO, 2293 - PENHA - RIO DE JANEIRO - RJ - 21020124

HEGV

Documento de Alta

|                     |                            |                     |                     |                    |                     |
|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Nome:               | IZALDO LAURENTINO DA SILVA | Sexo:               | Masculino           | Número Prontuário: | 033011              |
| Data de Nascimento: | 21/03/1962                 | Idade:              | 62A 1M 18D          | Data de Alta:      | 13/04/2024 09:06:05 |
|                     |                            | Data de Internação: | 08/04/2024 21:58:32 | BAE:               | 748136              |

Mãe: TEREZA GUEDES DA SILVA

Endereço: RUA OMAR FONTOURA, 131

Bairro: COELHO NETO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Motivo de alta: ALTA MEDICA

Conduta: ALTA MEDICA

Resumo da Internação:  
# PELA CG # TUMOR SIGMOIDE + OBSTRUÇÃO INTESTINAL # ADMISSÃO: PACIENTE, SEXO MASCULINO, 62 ANOS DE IDADE, ENCAMINHADO DA UPA, PENHA PARA REALIZAÇÃO DE TC ABDOME E Pelve + PARECER DA CG RELATO DE DOR ABDOMINAL DIFUSA, CONSTIPAÇÃO E VÔMITOS HÁ 5 DIAS PACIENTE APRESENTA DISTENSAO ABDOMINAL IMPORTANTE, SARCOPENIA, DESIDRATAÇÃO E HIPOCORADO; ABDOME INDOLOR A PALPAÇÃO, NAO DEPRESSIVEL; EUPNEICO EM AR AMBIENTE, AUSCULTA SEM ALTERAÇÕES MMH PULSOS PALPAVEIS SEM SINAIS DE EMPASTAMENTO # LAUDO VERBAL DE RADIOLOGIA: OBSTRUÇÃO INTESTINAL COM PONTO DE OBSTRUÇÃO COM MASSA EM TRANSIÇÃO COLON DESCENDENTE - SIGMOIDE; NÍVEL HIDROAEREO EM COLON, DELGADO; ESOFAGO PREENCHIDO; # NOTA OP: REALIZADO SIGMOIDECTOMIA A HARTMANN, PROCEDIMENTO SEM INTERCORRENCIAS LAB 0804: HB 10/ LEUCO 8500/ # AO EXAME PACIENTE VIGIL, COOPERATIVO, ANICTERICO, ADINAMICO, ESTÁVEL HEMODINAMICAMENTE SEM AMINAS, EUPNEICO EM AA SEM SINAIS DE ESFORÇO RESP, ABDOME CIRURGICO, FO LIMPA E SECA, SEM SINAIS DE PERITONITE OSTOMIA FUNCIONANTE PARA FEZES, ALGO PROLAPSADA, MUCOSA ROSEA, CD - DIETA PASTOSA - SEQUE CIPRO E METRO. - ORIENTO CINTA ABDOMINAL E DEAMBULACÃO - ALTA PELA CG

Resultado de Exames:

Tratamento:

Diagnóstico:  
C18.7 - Neoplasia maligna do colon sigmóide

Recomendações:

Data: 13/04/2024

MARCO AURELIO PINHO GALVAO  
CRM: 01212125 - RJ

Dr. Marco Aurélio Pinho Galvão  
CRM: 01212125-5

Evento 1, out2, pág. 23

Dados da Solicitação

ID Solicitação  
5684725

SMS CMS FAZENDA BOTAFOGO AP 33

Tipo de Solicitação

Tipo: Consulta

Consulta ou Exame: Ambulatório 1ª vez - Coloproctologia (Oncologia)

Dados do Paciente

CNS 70050367817450

Nome IZALDO LAURENTINO DA SILVA

Identificação do Solicitante

Médico Wagner Amada Oliveira

Hipótese Diagnóstica

Hipótese C18 - Neoplasia maligna do colon

Avaliação

Peso do Paciente (gramas): \*

78400

Altura do Paciente (cm): \*

178

IMC do Paciente: \*

2

Data da coleta da biópsia:

10/04/2022

Data do resultado da biópsia:

10/04/2022

Paciente já realizou cirurgia oncológica?

Sim Não

Unidade que foi realizada a cirurgia?

HMGV

Data da cirurgia:

09/04/2022

Queixa Principal: \*

EM ANEXO

A Câmara de Litígios em Saúde informou que, após consulta ao sistema SER, verificou-se que a parte autora encontra-se sob situação atual: EM FILA para Ambulatório: Ambulatório 1ª vez em Coloproctologia (Oncologia), desde 05/07/2024.

De acordo com os elemento constantes nos autos, entendo restar configurada a urgência no quadro clínico da parte autora. Observa-se que o prazo de 60 para consulta 1ª vez em oncologia já foi em muito extrapolado, uma vez que foi inserida em fila no **dia 05/07/2024** e diagnosticada em **05/2024** até o momento ainda não houve atendimento.

A gravidade de sua doença, que pode ser altamente agressiva, com sobrevida de semana a meses se não tratada, evidencia o *periculum in mora*.

O pleito de realização de consulta imediata sem observância da fila é possível, excepcionalmente, vez que a regra é a observância da fila. Porém, depende de comprovação concreta. Havendo nos autos comprovação da existência de risco de vida iminente ou alteração

do quadro que justifique mudança na posição da fila, tal será possível, em tese. E no caso concreto isso restou demonstrado como exposto acima.

O risco é de perecimento do bem que se pretende tutelar, devendo ser deferida a tutela de urgência pretendida.

**ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para que os réus providenciem, dentro de suas esferas de atuação, o agendamento da consulta em oncologia (Ambulatório 1ª vez) no âmbito do SUS para avaliação e início do tratamento oncológico no prazo de 10 dias. Sem custas e honorários. Publique-se. Intime-se. Após o decurso de prazo, dê-se baixa e archive-se.**